

先憤怒，再悲傷， 而且在當下

常見督導議題（二）：
技術面的困難

依據 Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. (第5章，pp. 107–140)

碩士層級臨床心理學教材 | 督導示例摘述自原書（原書已改寫以保密）

讀完這份資訊圖，你能夠……

1. 把「卡住」分成概念化、概念、知覺、行動、個人化
2. 區分第一層與第二層批評
3. 指出空椅微技巧中的錯誤並修正順序
4. 辨識受督者的自我批評與害怕深化
5. 說明「介入是手段，不是目的」
6. 把次發的絕望與核心痛苦分開
7. 依個人風格調整任務，並回到原則檢驗

卡住，會讓人放棄歷程

技術卡住 → 氣餒 → 懷疑同理與喚起 → 轉向給建議

為什麼要「符合模式」

特定的介入歷程已被證實能預測較佳結果（Greenberg, 2010）。

督導要做的

克服對情緒的恐懼；維持探索與發現的姿態，而非權威；以錄影逐刻示範什麼是歷程導向。

技術困難的三個領域

① 個案概念化

找不到核心、找不到焦點

② 介入

概念困難、知覺困難、行動困難

③ 個人化

讓技術適合受督者自己

每一種都是一個事件

標記 → 任務環境 → 受督者歷程 → 解決 (Exhibit 5.1–5.5) 。

概念化困難的標記與任務

標記

受督者感到不清楚、卡住，或覺得漏掉了個案的核心基模；或個案合作不穩固

澄清

卡在哪裡？什麼說不通？

概念理解

先請受督者說自己的理解

任務探索

探索受督者對核心痛苦的感覺

受督者的歷程與解決

受督者歷程

提供更多鮮明與痛苦的例子；聽片段時辨識原發與次發、適應與非適應；辨識核心情緒、敘事與關係主題；書面寫下概念化

解決

更清楚；能把逐刻歷程凝鍊為基模理解；找到向個案傳達焦點的方式

實用做法

下次督導前，寫下向個案說明概念化的方式，並在下次晤談前一起檢視。

一位找不到焦點的受督者

原書示例摘述

個案是幼兒園老師，曾兩度憂鬱，都在與有感情的男性分開後。這次，網路交友認識的男性結束了關係，她陷入嚴重憂鬱：「第三次失敗，我一定有很嚴重的問題。」她已請病假數月，面對困難感受時傾向理智化。

標記

受督者說不清楚怎麼處理她，找不到焦點。

「你最被什麼觸動？」

她說母親總是太擔心，她只能做母親安心的事。她覺得被困住，「像被剪了翅膀的鳥」，又覺得很罪惡。說「被困住」時聲音聚焦、有停頓，接著嘆了一口氣。

受督者

最重要的是她的罪惡感。

督導者

顯然有與母親的未竟事務。你最被什麼觸動？（受督者：她說被困住的方式）

要點

這份被觸動的感受，若被追隨，會指向核心情緒基模。

無望，是次發的

她為 35 歲還沒有真正的戀愛經驗感到悲傷，開始無望，說大多時間躺在床上。

督導者

她的無望是次發的症狀性情緒，要協助她觸及底層的核心痛苦。

第一個共構的概念化

她感到無望，因為看不出有誰會愛她；核心上覺得不可愛。

還不清楚：是斷線時的焦慮不安全，還是以羞愧為基礎的無價值感？

重新概念化，並等待標記

下一次晤談後

她會因為不理解的原因退縮；追隨自己活力的感受（興趣、享受）時，感到困惑、不安全；似乎無法把情緒當作資訊。

決定

母女關係很重要，但仍在背景中。等待清楚的未竟事務標記，再處理母親；目前先處理她對感受的理智化。

抵達核心，也保留另一條路

第四次晤談結束時

核心的非適應性感受：焦慮不安全。源於一位焦慮的母親，她需要的保護比女兒能給的更多；女兒從小避免讓母親焦慮，因而謹慎、害羞、退縮。

替代路徑

若她的罪惡感更強烈、持久，歷程可能發展成處理她對母親未解決憤怒的自我中斷。

教學要點

用受督者的觸動當羅盤；分開次發與核心；逐步修正。

介入困難的三個類別

概念困難

不理解任務的概念或程序

知覺、傾聽與跟隨的困難

沒看到、沒聽到線索與標記

行動困難

不知道做什麼、怎麼做、何時做

雙椅不是角色扮演

✗ 常見誤解

練習如何在真實世界對他人說話

✓ 真正的目的

雙椅：活化批評的聲音以喚起經驗

未竟事務：處理情緒

受督者也需要理解不同介入的一般步驟，透過教學與閱讀達成。

「為什麼要活化批評者？」

標記：對任務概念或程序的不確定。原書例：「我們不是要擺脫這個情緒嗎？」

督導者聽出五個領域的困難

介入的結構

步驟的順序

如何活化

如何深化

如何調節

補上理論的缺口

任務環境

重述理論與研究；補上缺漏；回答問題；看好與不好的介入錄影；回饋並舉例其他可用的介入；在督導外補足知識

受督者歷程

釐清困難領域；回想理論、記下參考資料；檢視介入並提問；自行觀看資深治療師的錄影

解決

概念更清楚；把閱讀與臨床情境連結起來

微標記：一個介入的機會

對個案瞬間表達或行為的觀察，它是一個介入的機會。

一聲嘆息

一個皺眉

一句鮮明的話

都是把個案的注意力引向當下經驗的機會。

督導怎麼練

聽錄影、逐刻暫停、擱置其他擔憂，搜尋微標記，想像個案此刻的經驗。

「我聽不出底下的情緒」

標記

難以調頻於經驗而非話語內容；難以理解此刻個案發生了什麼；難以「聽見」底下的情緒；難以掌握核心

澄清：卡在哪個層次？

微標記

特徵風格標記

投入模式

主要任務標記

以及治療焦點的指標

受督者練什麼？

練習	內容
成為個案	聽一句陳述時，覺察個案可能的經驗
辨識標記	傾聽並辨識不同的治療標記；發展焦點
量表評分	用經驗量表與喚起量表分析其他示例
評估生產性	注意、符號化、一致、接納、調節、主體、分化
練習回應	促進覺察與符號化；處理調節困難

知覺困難的解決

較清楚的焦點；能辨識並區分個案的標記

能把傾聽技能類推到更複雜的情境

更有效率地回應個案的標記

「接下來要做什麼？」

在同理之外，發展進階的介入：椅子工作、意象。

原書示例

一位同理能力已經很好的受督者，對某位個案沒有進展，不知道接下來要「做」什麼。督導者以她既有的技能為基礎，示範並練習不同任務的步驟。

所有介入的共同目標

取用核心情緒基模，所以常要練習活化情緒的技能。

行動困難的任務環境

澄清

困難在同理本位、關係、再處理，還是重新演出的任務？

任務探索

提供具體例子；聽片段，任一方需要時暫停；以「可以做」而非對錯工作；逐刻探索整個任務、某一步驟或流暢融合；有治療阻礙時深化受督者的經驗

練習

思考不同的介入選項，並實際練習

帶回結果，直到流暢

受督者歷程

摘要概念化；重述核心情緒與焦點；聽片段，在困難處暫停；規劃下次的介入；帶回新介入的嘗試結果，一起檢視，直到熟練；學習任務步驟；觀看示範錄影

解決

使用不同介入時越來越熟練、流暢

「我應該更聚焦他的羞愧……」

受督者與 31 歲社交焦慮男性個案的晤談（原書示例摘述）

受督者（意譯）：「我當時腦中在想要不要做椅子工作，所以分神了。我知道我需要更能讓他進到內在。他的語氣和話很不一致，讓我困惑。」

原教材的觀察

自我批評常出現在有能力、敏感的治療師身上，會妨礙學習，尤其是做中學。

督導者怎麼回應？

一般

正常化（帶點幽默）：「本來就很難完美，反正也沒有完美的方式。」

肯定能力：「你做得很好！」

持續自我批評時

在認知層次稍微拆解受督者的批評者；不做治療或雙椅，因為此刻的督導契約不包含個人工作。

若似乎適合

討論個人工作是否有幫助，需要時轉介。

害怕啟動雙椅、加深分裂

- 1 更具體地探索：晤談中發生了什麼
- 2 釐清想學什麼：如何介紹雙椅、如何建立分離與接觸、如何取用底層感受
- 3 深化受督者的困惑與「治療阻礙」
- 4 建議如何設置兩邊

較長期的阻礙

有時做經驗性工作，但更常以同理探索處理表現焦慮或概念困惑。

「沒有安全網」

原書示例摘述

個案害怕進入痛苦之處會卡住，唔談後無法把自己拼回去，沒有人幫他收拾。他的自我中斷阻止他深入投入。

受督者不敢「推」他

害怕破壞同盟、害怕失去個案、擔心個案承受不了痛苦。

原教材

這是督導中常出現的重要問題：受督者對痛苦情緒的恐懼。

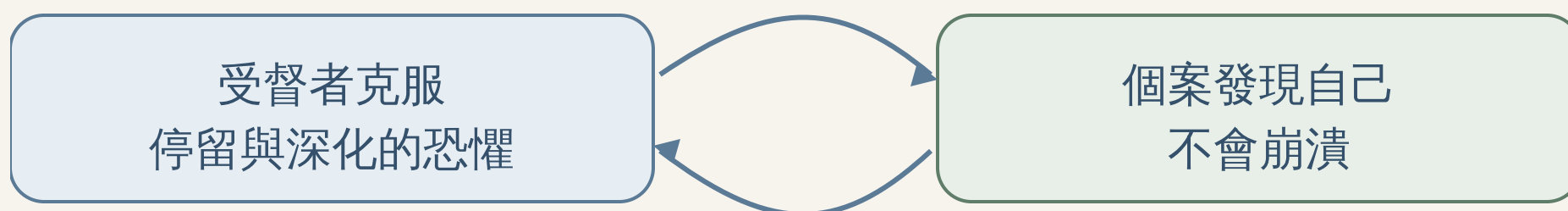
督導者的四個步驟

- 1 先確認沒有深化的禁忌
- 2 驗證受督者的恐懼
- 3 引導受督者停留在情緒中，而不是迴避
- 4 覺察自己的恐懼、中斷它、學會忍受自己的情緒

界線

督導者不活化受督者畏懼的痛苦情緒，那屬於經驗性訓練或個人治療。

治療師的恐懼， 會變成個案的天花板



兩個層次的心理教育：督導者對受督者，受督者對個案。更重要的是，受督者自己面對過痛苦情緒並活了下來，這通常在督導之外進行。

個案第一次揭露羞愧之後

✗ 迴避

會證實這件事羞恥到無法談論。

✓ 下一次晤談主動提起

表達很高興個案信任自己，信任到願意打破家規說出來。

原書示例接著

個案說自己非常卡住：一輩子被告知「這件事不存在」，唯一能繼續下去的方法是「閉嘴」，否認它影響了自己。

介入是手段，不是目的

受督者在晤談中迷失：同時出現未竟事務、自我厭惡、自我中斷的標記，想太多下一步要往哪裡走。

有幫助的概念化

用哪個介入、跟隨哪個標記並不重要，只要抵達核心感受，並觸及對接納與驗證的需求。

結果

受督者理解了痛苦情緒的核心地位，回到跟隨個案的經驗。

第一層 vs. 第二層批評

	第一層批評	第二層批評
是什麼	核心的、針對性格的批評	因為有問題而批評自己
例子	「我沒有價值」→ 憂鬱 「我很笨」→ 焦慮 「我沒有才能」→ 拖延	「我好氣自己這麼憂鬱／焦慮／拖延」
要做的	取得它	不要停在這裡

原教材

即使概念上學過，通常仍要犯錯並被指出才學得會。

「你為什麼不表達想法？」

個案在家庭情境中無法堅持自己，總是說「都聽你的」（原書示例摘述）

督導者：這是第二層的教練式批評者

她在批評自己不表達。真正的問題是她抑制自己，要找到阻止她表達的核心批評。

她說：怕出錯被怪，所以猶豫

督導者：「所以你要說：『過來這裡，讓她沒有自信。』」

負面評價，加上嚇唬自己

批評者：「你太愛批評別人……他們會拒絕你。安靜。」

督導者：這是第一層批評，同時包含負面評價與嚇唬自己，要發展這兩者。

✗ 「告訴她，你總是在討好別人。」

又回到教練式批評者：批評自己被抑制。

✓ 「看著她的眼睛，她做錯了什麼？批評她。」

可能得到更多第一層批評：你很笨、自私、醜……

無法用指令取得感受

人必須先抵達一個地方，才能離開它；督導者只能領先一步，仍在近側發展區內。

治療師無法用指令取得感受，只能跟隨並促進它浮現。個案需要自我組織，以新的方式經驗自己，而不是「理解」某件事。

教 EFT 的長久問題

成為對歷程敏感的新經驗促進者，而不是修改者、教導者、理解的提供者。

「你有沒有一些憤怒？」

督導者

太早取用憤怒。她的聲音、姿勢、話語中沒有任何憤怒的跡象。應該請她去製造焦慮的椅子，讓自己害怕。

治療師接著長篇解釋憤怒

督導者：讓她多做中斷，當她開始組織成肯定的自己時，再對抗壓抑者。你想促進的不只是洞察。

要促進的是

感覺到自己是製造痛苦的能動者；讓身體投入；對抗批評與中斷聲音的動機。

最大的困難之一：看不見中斷

受督者難以看見中斷的歷程，也不知道如何介入。

治療師：「你會依別人的反應調整自己，像結凍一樣。」

督導者：這時可以引入自我中斷的分裂，她在阻止自己。

治療師：「問題在這裡……你懂嗎？」

督導者：你在提供理解，這很好。但還需要創造一個經驗，轉入中斷的對話。

把「被做」變成「在做」

個案停下來：「我好像忘了要說什麼……像失憶。」

被做

「它就這樣發生在我身上。」

在做

「過來這張椅子，讓她忘記。
你怎麼做到的？」

督導者

這是當下的中斷。讓個案經驗到自己是中斷的能動者。

聲音變低，接著變硬

個案談到不被父母理解：遺憾、失望、一些怨恨、有什麼缺了。聲音變低、變小，像轉向內在卻找不到；接著以變硬的聲音、撇嘴從中出來。

督導者

這是未竟事務的標記，以前出現過。現在就利用這個機會，和她的父母對話。

不是角色扮演， 是重組內在的自我—他人基模

「過來這裡，做做看。」要幫她有一個經驗，而不只是洞察：演出父母，並經驗到自己有能動性，能對抗她內在建構的父母。

✗ 不是

練習如何對真實世界的父母表現

✓ 而是

重組內在的自我—他人基模

一段對進階受督者的 空椅微技巧督導

原書示例摘述；督導者事先看過錄影

困難一

請個案演出重要他人的負面（此例是忽視的他人）

困難二

從敘事的描述（發生了什麼、當時感覺什麼）移到當下的經驗（此刻在晤談中對對方的感受）

接下來

十三條微技巧原則。

從經驗性接觸開始

1 ✕ 從敘事開始

「把媽媽放在這裡，告訴她『我有點擔心兒子』。」

1 ✓ 先接觸

「把媽媽放在這裡。你看得到她嗎？看到她時，你感覺到什麼？」

2 小細節會累積

「我知道你很擅長。但這些雖然微小，卻會累積。」

3 及早接住憤怒

她一開始就說「我很生氣」：「看得到她嗎？告訴她『我很生氣』。」

把她帶到當下

4 避免評價性的語句

「這聽起來很表面，能從更深的地方說嗎？」即使溫和，也可能讓她覺得被評判。

5 太多敘事，要深化情緒

她在抱怨。把抱怨分化為底下融合的憤怒與悲傷。

6 關鍵問句

「你說這句話時，現在感覺到什麼？」帶到經驗性的當下；問「那時」則引出認知處理。

內容與歷程可能不同

內容

「我覺得被忽視。」

歷程（語調）

怨恨

問「你說這句話時感覺到什麼？」能幫她連結到憤怒。有時相反：內容是憤怒，當下卻是悲傷。

此刻：「我很生氣，因為我過去被忽視。」

停在敘事的第二層：「你那時感覺什麼？」「我覺得被忽視。」

太早換椅，會變成辯論

✗ 她在抱怨時：「過來，媽媽會怎麼說？」

媽媽：「你一直是個難搞的孩子。」 → 母女辯論

兩個最好的選項

(a) 對話早期

「過來這裡，當那個忽視你的媽媽。」

(b) 對話後期

觸及痛苦與深層需求後：「媽媽怎麼回應你的感受和需要？」

演出她心中的那個媽媽

個案心中有一個轉身離開、推開她、摀住耳朵的母親形象。要演出它，直到它在個案心中被活化，那就是核心情緒。

理想的說法

受督者看到的是讓人罪惡、責怪人的母親：「過來這裡，當你那個責怪人的媽媽，責怪她。」

不要變成

「如果她打電話給媽媽，會發生什麼」的角色扮演。

「真可悲」→「我很生氣」

拒斥性憤怒

「真可悲。」評判與厭惡；
「你」的責怪形式

賦能的憤怒

「告訴她你氣什麼。」「你可以告訴她『我很生氣你』嗎？」

重點

要直接，從「你……」的責怪，移到「我……」的表達。

先清出憤怒，悲傷才會深

人在抱怨時，憤怒與悲傷是融合的，通常要先取得憤怒，才能取得悲傷。

若跳過憤怒，直接找悲傷

憤怒仍停在敘事形式，沒有被符號化與處理，悲傷就不會那麼深。

督導者自己說

「這是一個假設。」

兩種需求

憤怒中的需求

表層的需求，與憤怒相連

悲傷中的需求

深層的需求，以及思念

受督者問：「悲傷在需求之後嗎？」

督導者：是的，下一步是觸及原發的悲傷，以及悲傷中的深層需求。

依核心需求決定換椅時機

在憤怒時換椅

像婚姻中的爭吵，媽媽會辯護。

核心是依附、渴望

先到悲傷：「我需要你靠近。」→「再告訴她一次」→
「你說這句話時感覺到什麼？」→「告訴她你思念什麼」

母親曾有虐待

憤怒才是換椅的時機，因為那是適應性、守護界線的回應

「先憤怒，再悲傷。」
「而且在當下。」

對進階受督者

需要的是精煉技能，而不是手把手的陪伴。

督導者也在示範

督導中出現理解上的落差時，督導者透過溝通，最後承認自己的誤解，預防了潛在的裂痕。

「試探一點開始，
感覺比較好。」

標記

偏好某個介入；想調整步驟以符合個人價值；或督導者注意到受督者不太敢說出偏好

原書示例

受督者覺得以較試探、有準備的方式開始雙椅，會比毫無預警地請個案演出批評者「感覺比較好」。督導者探索調整步驟的替代方式。

為什麼重要

把人格融入介入，才能傳達真誠，變得真實而一致。

個人化困難的任務環境

澄清

以具體例子表達對個人風格的需要

探索替代方式

為什麼偏好？對自己與個案的好處？提供何時、做什麼、如何做的替代方式；鼓勵自由選擇，同時提供足夠的引導

同理反映與驗證

支持個人風格；不評判地指出可能的脆弱之處；驗證受督者是自己治療經驗的專家

直到「感覺對了」

受督者歷程

把偏好連回 EFT 原則；權衡利弊；嘗試不同方式；監測自己對介入的情緒反應，直到「感覺對了」；強調個人優勢；整合個人風格與後設溝通

解決

感到被鼓勵、被啟發，以個案為念發展個人的介入風格

技術回饋越多， 越需要支持的關係

EFT 督導給予非常具體、逐刻的技術回饋。

若沒有一段被經驗為真誠而接納的高度支持性關係，受督者可能會感到被批評。

督導始終關注

督導者與受督者之間，以及治療師與個案之間的關係。

本章的整合模型

困難	標記	任務環境的核心
概念化	卡住、漏掉核心	澄清、概念理解、書面概念化
概念	不懂為什麼	補理論、看錄影、作業
知覺	聽不見情緒	逐刻暫停、成為個案、量表練習
行動	不知道下一步	「可以做」、練習、帶回結果
個人化	偏好、想調整	探索替代方式、驗證

介入只是路

「介入是抵達核心情緒的手段，
本身不是目的。」

“The intervention is a means to getting to the core emotion, not an end in itself.”

臨床意義

焦點回到個案的核心情緒。

教學重點

不要把治療變成「辨識 → 套用」。

感受無法被命令

「治療師無法用指令取得感受；
必須跟隨，並促進它浮現。」

“The therapist cannot access feelings by instructing them; the therapist has to follow and facilitate their emergence.”

臨床意義

「你有沒有憤怒？」常常沒用。

教學重點

創造讓感受浮現的條件。

從故事到當下

「故事一開始是好的，因為它們觸及感受；但它們不會把她帶到當下。」

“The stories are good at first because they get at the feeling, but they don’t bring her to the present.”

臨床意義

改變發生在此刻的情緒中。

教學重點

「你說這句話時，現在感覺到什麼？」

七個常見誤解

常見理解	更精確的理解
椅子工作是練習真實對話	喚起經驗、重組內在基模
要選對介入	介入是手段，跟著痛苦走
讓個案懂了就好	要創造經驗，不只洞察
批評者罵自己就對了	要取得第一層批評
讓個案扮演對方回應	早期先演出負面他人
直接找悲傷	先清出憤怒，在當下
不深化就是保護個案	可能在保護治療師自己

「你那時候感覺什麼？」
「我覺得被忽視。」

✗ 錯在哪裡

停在敘事的第二層；語調其實是怨恨，卻沒被接住。

✓ 修正

「你說這句話時，現在感覺到什麼？」→「我很生氣。」→「告訴她：『我很生氣你……』」→之後再問：「現在感覺到什麼？」
→ 悲傷與思念。

檢查一下你記住了什麼

Q1 「我好氣自己一直拖延。」這是第幾層批評？

Q2 受督者說：「我聽不出她底下的情緒。」這是哪一類困難？

Q3 空椅中，個案在抱怨時，為什麼不要請她換到媽媽的椅子？

Q4 在什麼情況下，憤怒才是空椅換椅的正確時機？

解答與一句話說明

A1 第二層。要找到背後的第一層批評，例如「我沒有才能」。

A2 知覺、傾聽與跟隨的困難。逐刻暫停，練習辨識微標記。

A3 會變成母女辯論，媽媽會辯護，而不是喚起痛苦經驗。

A4 母親曾有虐待時：憤怒是適應性、守護界線的回應。

受督者說「我卡住了」

檢驗問題	若答不出來 → 類別
最觸動的時刻是哪裡？	概念化
這個任務的目的與步驟？	概念
錄影中能指出標記嗎？	知覺
能說出下一句回應嗎？	行動
想用自己的方式做嗎？	個人化
描述時很焦慮、自責嗎？	受督者的恐懼或自我批評

空椅對話的八個檢查點

1 看得到她嗎？

2 敘事還是經驗？

3 內容與語調一致嗎？

4 「你」還是「我」？

5 憤怒清出來了嗎？

6 悲傷中的深層需求

7 何時換椅？

8 依附或界線？

雙椅對話的推理

問題	做法
第一層還是第二層批評？	第二層 → 找阻止她的核心批評
批評夠具體嗎？	從洞察轉為具體情境的演出
有憤怒的線索嗎？	沒有 → 先演出讓自己害怕
出現中斷了嗎？	「被做」→「在做」
我在給理解，還是創造經驗？	理解 → 轉入對話

這對實務意味著什麼？

面向	本單元的意涵
概念化	以觸動為羅盤；分開次發與核心；逐步修正
介入	手段不是目的；經驗重於洞察
雙椅	第一層批評；具體；「在做」
空椅	接觸、當下、「我」、先怒後悲、依需求換椅
受督者	正常化自責；驗證恐懼；個人工作在督導外
關係	回饋越多，越需要支持

哪些主張有證據？

主張	證據性質
特定介入歷程預測結果	Greenberg（2010）整理的歷程—結果研究
第一層 vs. 第二層批評	臨床理論，本章未引研究
先憤怒後悲傷	督導者明言是假設
依附 vs. 虐待決定換椅時機	臨床理論
治療師克服恐懼 → 個案也能	臨床觀察
各 Exhibit 的受督者歷程	作者整理，尚待研究

還沒有答案的問題

1. 「先憤怒後悲傷」在哪些個案或文化中可能不適用？
2. 讓個案扮演責怪人的父母，什麼時候可能造成傷害？
3. 深化前的「禁忌」具體包括哪些？誰來判斷？
4. 個人化的調整到什麼程度，就不再是 EFT？
5. 受督者的恐懼何時該在督導中處理，何時該轉介？

四個層次的學習

必須記住

三大領域；介入困難三類；五個 Exhibit；兩層批評；空椅十三條原則

必須理解

介入是手段；感受無法被命令；經驗重於洞察；恐懼的循環

必須能夠應用

分類「卡住」；取得第一層批評；問「現在感覺到什麼」；「我」語言；依需求換椅

必須能夠質疑

假設性的順序；扮演負面他人的風險；個人化與忠誠度

感受無法被命令， 只能被邀請浮現。

主要來源：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. Washington, DC: American Psychological Association. 第5章 (pp. 107–140)。

原書引用：Greenberg (2010)；Auszra et al. (2013)。

Exhibit 5.1–5.5 經改寫重構；督導示例為原書內容的摘述，原書已改寫以保密。

下一單元：研究與未來方向（第6–7章）